PGY 兒科 Orientation

Fellow 范琦、馬于婷

Check list

- ★ 兒科常用藥物手冊（2018）
  - 小黃本子：9L醫師讀書室
  - 各層樓討論室
  - 電子檔：網頁+掃描檔
- ★ 資訊管道：Email, Team plus
  - 科秘寄Email:
    - 胡家睿--班表, 兒科orientation資料
    - 王韻涵--學術活動表, PGY課程
    - 陳盈如--教學門診表
  - Team plus
- ★ 教學門診及表單：9L醫師讀書室
- ★ 學術活動：星期二三五晨會 星期二五noon meeting 其他各次專會議
- ★ 值班特休請假-->當科fellow

工作規範

Primary care



- Clerk 1: 1床
- Clerk 2: 2~6床
- **PGY1 8床**, PGY2 4-12床
- R 15床

若超過上限請當科cover fellow 調控人力。

工作時間

07:30~16:30 上下班時間，前後一小時打卡不為異常

- 本科VS多習慣在晨會後馬上查房，請務必在查房前看完當科病人並準備整理其data、vital sign、I/O 等資料。
- 接病人時間，以病人到護理站報到時間為準，請各位醫師離開醫院前務必確認teamplus訊息看是否有新病人未接
- PM off 時間為11:30(R)，Day off 時間為07:30(PGY)
- 接新病人務必確認住院通知單上是否有VS order

16:30(含)~

- 當科Team 上critical的case請在下班前交班給值班醫師。若有另外處置或檢查須在值班請值班醫師幫忙也請確實口頭交班
- 每日需在24小時內完成電子簽章

PGY Day off

- 2020年8月實行PGY 1 值班隔天day off制, 2021年8月實行PGY 2值班隔天day off制
- 值班日為W7~ W4 ，day off時間為隔日早上7:30
- Day off 交班時間為值班當天的16:30-17:30
- 若星期天值班，應於星期五下班前與代理人交班
- 交班內容：重點式交班口頭交接照顧病人數及狀況、病情嚴重或特殊狀況之病人需至HIS系統完成紀錄
- 代理人須跟查房以及完成cover team order及note，若禮拜一需cover其他team，請先將cover team所有病人包括假日新病人看過一輪
- Day off前請暫存Progress note, Weekly summary, Discharge note

享有權利同時也須盡義務

出院開立

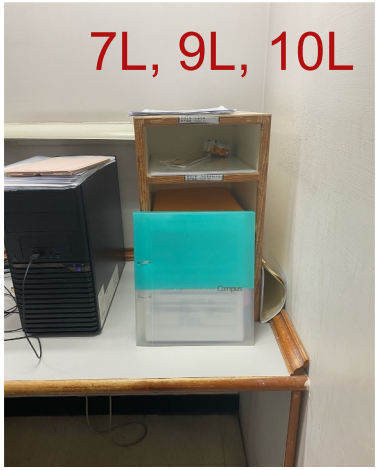
- 今辦今出(Discharge today)請盡可能在當日10:00前開完，若遇需要改當日出院帶藥請儘早更改開立，加速床位釋出
- 今辦明結(Discharge tomorrow)開立時間不限

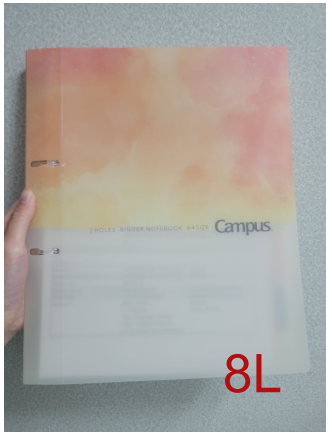
值班

- 值班時間：16:30後開始處理complaint，直到隔日07:30下值班。若是假日值班則為08:00開始值班。
- **16:15-07:00** 為平日值班接新病人時間(新生兒科另訂，需另外詢問新生兒科fellow)(2023.12.04起實施)
- 23:00-05:30鎖床
- 下值班前務必確認當樓層新病人是否都有探視及開立醫囑。
- PGY1值班接新病人**上限: 平日5床; 假日9床**
  PGY2值班接新病人**上限: 平日10床; 假日15床**
  Clerk 2值班接新病人**上限為2床 （請平日值班時聯絡當天需夜間學習的clerk）**
- **值班隔日一早新病人超過第三個（含）**，可以call Clerk2 幫忙接一床，可以考慮請上線醫師調度其他病房樓層醫師幫忙(但若其他樓層也都有兩床以上新病人，就請當樓層值班醫師自己接完)。
- 有問題的case務必請教上線或總值
- 病人有特殊狀況者請打duty note
- 病人轉ICU**請通知當科主治醫師**並完成transfer note

值班

- Cover病房**LW (病房總值)**請查看當天班表
  - 病房有任何疑問請call LW
    有緊急狀況也可同時call **IEM (全兒科總值)**。
  - 值嬰兒室有疑問請找**6L**醫師。
  - ****請注意若當日沒有IEM只有EM, 病房二線改6L, 嬰兒室二線改3A!!**
- 推床&CPR支援
  - 原則上值班**8B醫師**協助，上線醫師可視情況調度。





值班常見order開立

- Seizure病人一率開O2 flow and valium PRN

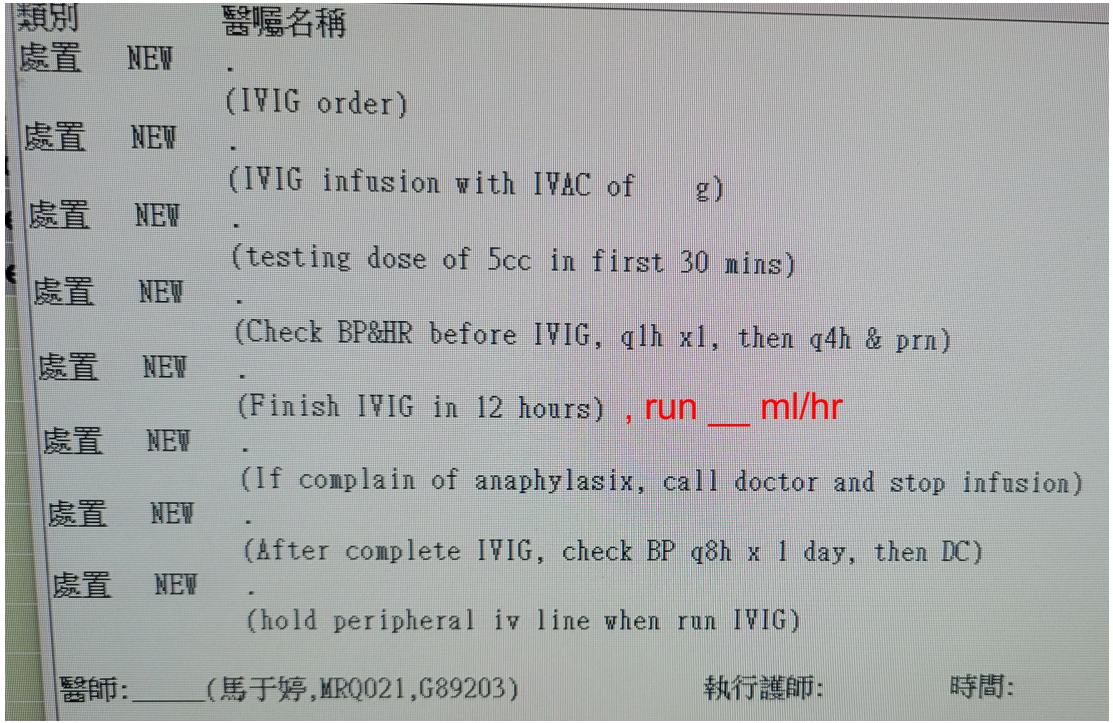
開立方法如下：

1. 呼吸治療開立: O2 flow PRN if seizure
2. 藥物開立valium IV (BW/4 mg), 若穩定後無IV可改valium supp (BW/2 mg) PRN if seizure
3. 文字order free typing: O2 flow and valium 多少mg IV(or supp) PRN if seizure

值班常見order開立

- IVIG order開立:
  醫藥囑他科範本-> 4A800
  兒童過敏氣喘風濕科->
  IVIG order

- 藥物1PC是3gm/50ml。
  計算總total ml後，算
  __ml/hr的時候請記得扣掉
  testing dose 5ml, 再除扣
  掉testing 時間30mins後
  以11.5hrs來計算



重要第六大核心技能

- 開立檢查
  - 註明age, indication
  - 新生兒科除健保適應外，要**額外備註**實際排檢查理由。
  - 心超 for Kawasaki, 要註明BH,BW
  - 相關sedation/同意書
  - 開立bronchoscope, chest echo請先聯絡chest CR, 確定時間後再開立檢查單
- 開立照會
  - 找時間打電話跟fellow報case



*兒童腦部超音波

2023/05/15 PAGE: 1

22113712 女 健保 P03L0316 PNICU1
翁榆柔之女 出生年月日:2023/04/11 楊長佑醫師
日期:2023/05/15 11:26 卡號:0009 診斷碼:P0731
IC卡器官捐贈及安寧緩和醫療註記:無

$M32-061 001 NEONATAL NEUROSONOGRAPHY
(1120515 1126)
(早產兒出血追蹤)
TOTAL ITEM : 1

*兒童腦部超音波

2023/05/14 PAGE: 1

22113328 女 健保 P03L0315 PNICU1
蘇沄沄 出生年月日:2023/02/21 朱世明醫師
日期:2023/05/14 09:29 卡號:0001 診斷碼:P0726
IC卡器官捐贈及安寧緩和醫療註記:無

$M32-061 001 NEONATAL NEUROSONOGRAPHY
(1120514 0929)
(f/u for bilateral Subependymal Hemorrhage with resolution
TOTAL ITEM : 1

開單醫師: 阮昱棠 批價
長庚紀念醫院

2211328

8B值班: 8L+嬰兒室, 送檢查, 支援CPCR



"8B": 負責BR新生兒order及PE。

- **0AM-6AM休息（沒狀況護理站不扣）**
- 開立住院單

8B值班: 嬰兒室

"8B": 負責BR新生兒order及PE。

- 幫新生兒科宣導
  - 進嬰兒室請記得要洗手，穿隔離衣。
  - 值班時嬰兒室order覆核跟有問題請先找6L，6L無法處理再找總值。

8B值班: 嬰兒室

"8B": 負責BR新生兒order及PE。

- 新生兒order: BR(位置：3K)小辦公室內桌上，有一份護貝order說明，照著上頭一步一步開即可（已附上照片）。【範本：新生兒科>嬰兒室出入院醫囑範本（藥囑*K1*眼藥也要帶出（**請記得手動在藥囑加上1QS帶出藥量**），***B*肝另外單獨開**），其他有特別需求的抽血醫囑，皆在新生兒科範本裡】。
  【註：林如立醫師掛為遺傳科，請**另外點他科範本再選新生兒科**帶入醫囑】
- **嬰兒室 “新生兒自費篩檢” 請一律點選自費使用，切勿以手動輸入備註，以免計價有問題**。【範本：新生兒科>嬰兒室*:* 新生兒自費篩檢>跳出視窗全部點選*OK*>最右邊*“*註記*”*點選*“F-*自費*”*】（隨信附上教學影片）。
  注意！新生兒自費超音波請記得點範本裡的，不要手動自己開。醫院項目代碼很多但不一定是兒科的

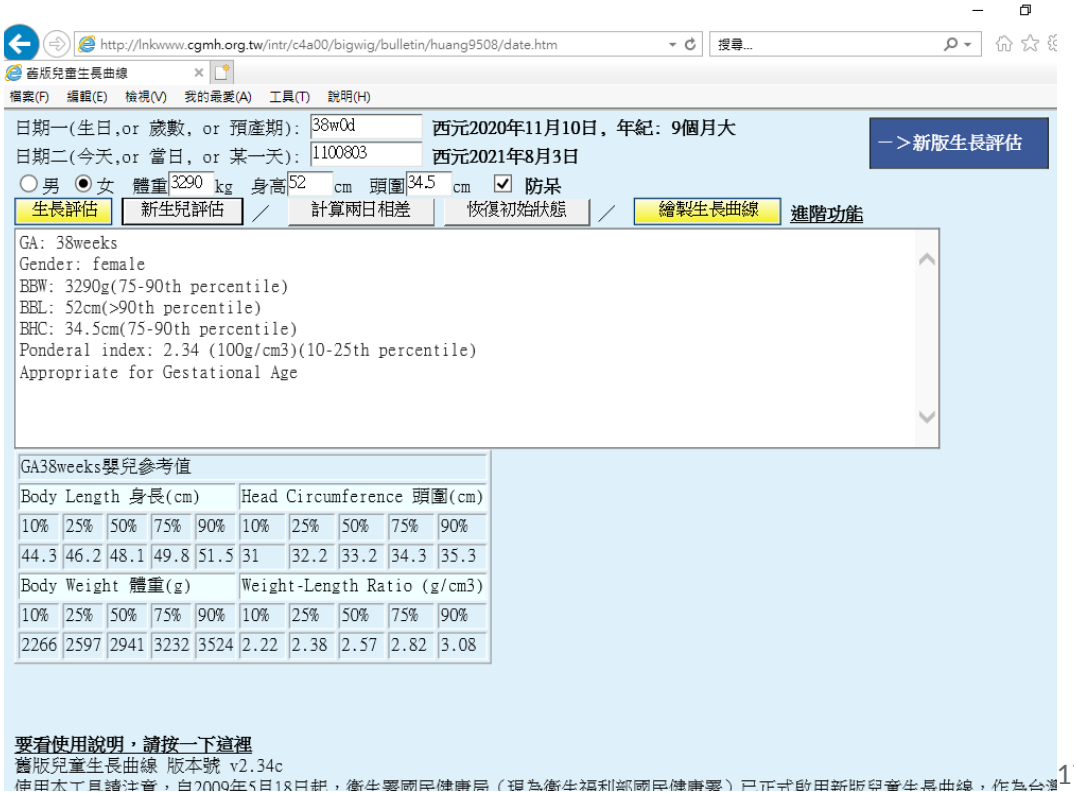
8B值班: 嬰兒室

"8B": 負責BR新生兒order及PE。

- 新生兒PE: 教學檔案如附件
- 請確實將PE finding打入admission note中的理學檢查及Impression中，ex. Undescending testis, hydrocele, heart murmur, Caput succedaneum…
  - 若有特別發現，請告知護理師作紀錄
  - 有轉床需求時（例如：喘凹、cyanosis、持續性嘔吐）請聯絡上級醫師，並記錄在admission note/transfer note中。【範本：新生兒科>嬰兒室出入院醫囑範本】。

8B值班: 嬰兒室

“8B”: newborn admission的身高體重頭圍



8B值班: 嬰兒室

住院單開立-->任選病人(BR有流程)

1. 從「功能選單」「常用功能」「開立住院單」進入

進入後會問你是否要重覆開立住院單 先選「是」

2. 填寶寶 病歷號/主治醫師代碼/診斷碼/住院日期（當日）

3. 存檔列印

4. 填床位和入院時間

- 病歷號/主治醫師/床位/入院時間 都可問護理師

值班室

- 值班室

  06L 10L 09L 各有男女生值班室各一可使用

  密碼 xx96, e.g 9096

  由LW分配床位

  *若有遇到值班室設備問題需報修，請掃QR code線上報修並通知負責值班室的fellow，協助fellow在將來確定報修是否完成

值班服

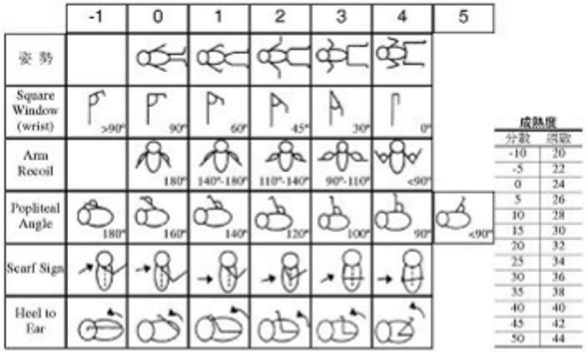
- 5L討論室
- 8K開刀房
- 急診1F
- B1洗縫組
- 12L舊科辦

接妞胚

- 看過病人再存出order
- Admission order: O2?/Monitor/IV/Antibiotics/symptomatic medication
- Admission note範本：兒童感染科 ：病歷範本
- 帶clerk接胚：確認百分位 出生疫苗史 PE/vital sign

新生兒成熟度評估

神經肌肉成熟度（Neuromuscular Maturity）



成熟度	
分數	週數
-10	20
-5	22
0	24
5	26
10	28
15	30
20	32
25	34
30	36
35	38
40	40
45	42
50	44

身體成熟度（Physical Maturity）

	-1	0	1	2	3	4	5
皮膚	油黏狀 易碎、透明	黏膠狀 紅、半透明	平滑粉紅 可見靜脈	表面有可剝落的小裂片 或有合算皮紋 可見少數靜脈	表面的小裂紋 部分可見粉 靜脈	平皮紙般的 被覆的小裂紋 看不見靜脈	柔軟的 皺褶的
胎毛	無	稀疏	豐沛	稀少	已現無胎毛區域	大部分區域無胎毛	
腳掌紋	無明顯紋路 4-5 公分：-1 < 4 公分：-2	> 五公分無腳掌紋	已現模糊的紅色紋路	腳掌前半部有橫紋	掌紋已現在腳掌前 2/3	掌紋布滿腳掌	
乳房	摸不出來	不太能摸出來	平的乳暈無乳腺	乳暈上出現一些小點 1-2 公釐大小的乳腺	乳暈的乳腺 3-4 公釐大小的乳腺	發育之象的乳暈 5-10 公釐大小的乳腺	
耳/耳	耳殼軟合 未分開 軟合軟骨：-1 軟合軟骨：-2	耳殼可打開 扁平的耳殼 無法回彈	耳殼軟降曲 軟、回彈慢	降曲的耳殼 軟、回彈快	已成形耳殼 硬、 回彈迅速	厚實的 耳殼軟骨 硬	
男性生殖器	陰囊扁平 表面平滑	陰囊空洞 內無睪丸 表面皺褶很	睪丸在陰囊內 管上半部 表面出現幾少 數皺折	睪丸位置降下 陰囊 少數皺折	睪丸已降下 於陰囊中 已形成良好 皺折	睪丸已降下 於陰囊中 已形成良好 深度皺折	
女性生殖器	陰蒂顯著 陰唇扁平	陰蒂顯著 小陰唇 不顯著	陰蒂顯著 小陰唇增大	大小陰唇 等大	大陰唇 顯著增大 小陰唇 開始較小	大陰唇 包覆住陰蒂 及小陰唇	

圖 3-1 經由成熟度評估懷孕週數（New Ballard Scores）

J Pediatr 1991; 119: 417.

Neuromuscular Maturity

Score	-1	0	1	2	3	4	5
Posture							
Square window (wrist)	>90°	90°	60°	45°	30°	0°	
Arm recoil		180°	140°–180°	110°–140°	90°–110°	<90°	
Popliteal angle	180°	160°	140°	120°	100°	90°	<90°
Scarf sign							
Heel to ear							

Physical Maturity

Skin	Sticky, friable, transparent	Gelatinous, red, translucent	Smooth, pink; visible veins	Superficial peeling and/or rash; few veins	Cracking, pale areas; rare veins	Parchment, deep cracking; no vessels	Leathery, cracked wrinkled
Lanugo	None	Sparse	Abundant	Thinning	Bald areas	Mostly bald	
Plantar surface	Heel-toe 40-50 mm: –1 <40 mm: –2	>50 mm, no crease	Faint red marks	Anterior transverse crease only	Creases anterior ⅔	Creases over entire sole	
Breast	Imperceptible	Barely perceptible	Flat areola, no bud	Stippled areola, 1–2 mm bud	Raised areola, 3–4 mm bud	Full areola, 5–10 mm bud	
Eye/Ear	Lids fused loosely: –1 tightly: –2	Lids open; pinna flat; stays folded	Slightly curved pinna; soft; slow recoil	Well curved pinna; soft but ready recoil	Formed and firm, instant recoil	Thick cartilage, ear stiff	
Genitals (male)	Scrotum flat, smooth	Scrotum empty, faint rugae	Testes in upper canal, rare rugae	Testes descending, few rugae	Testes down, good rugae	Testes pendulous, deep rugae	
Genitals (female)	Clitoris prominent, labia flat	Clitoris prominent, small labia minora	Clitoris prominent, enlarging minora	Majora and minora equally prominent	Majora large, minora small	Majora cover clitoris and minora	

Maturity Rating

Score	Weeks
-10	20
-5	22
0	24
5	26
10	28
15	30
20	32
25	34
30	36
35	38
40	40
45	42
50	44

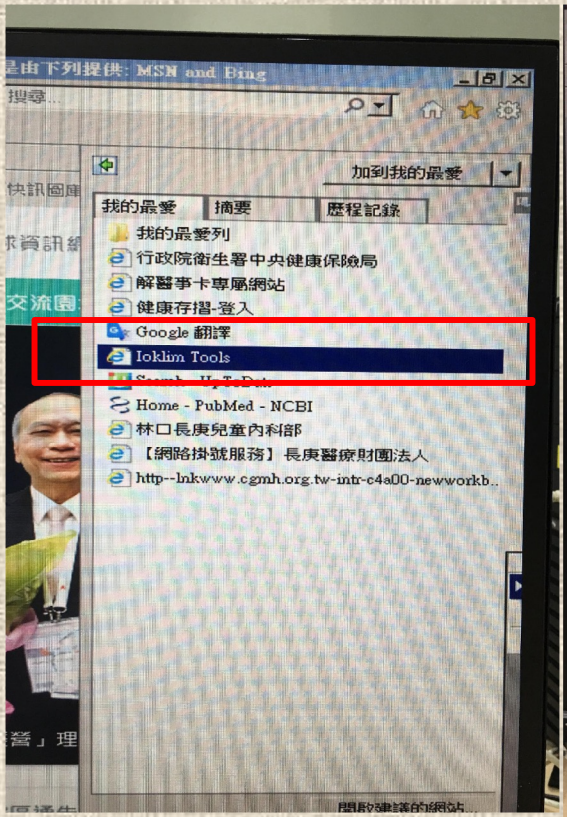
病歷紀錄

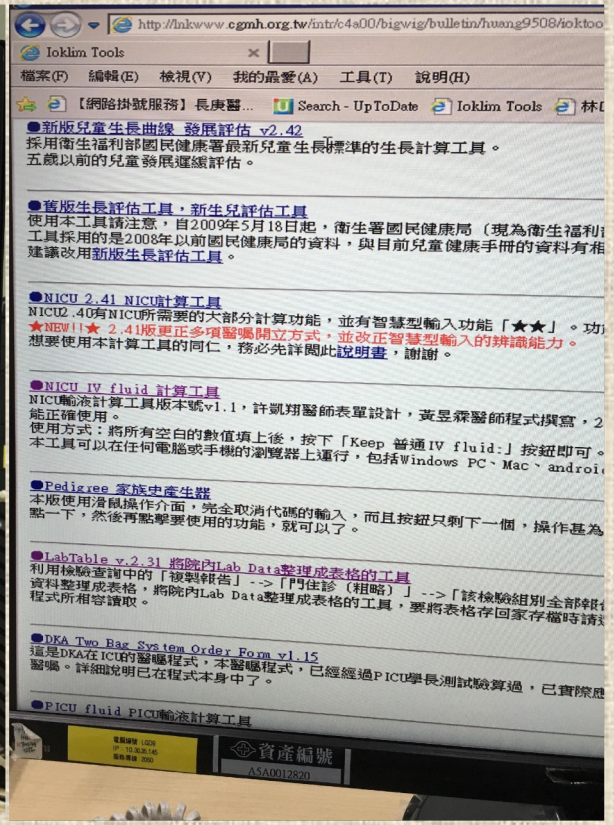
Admission note

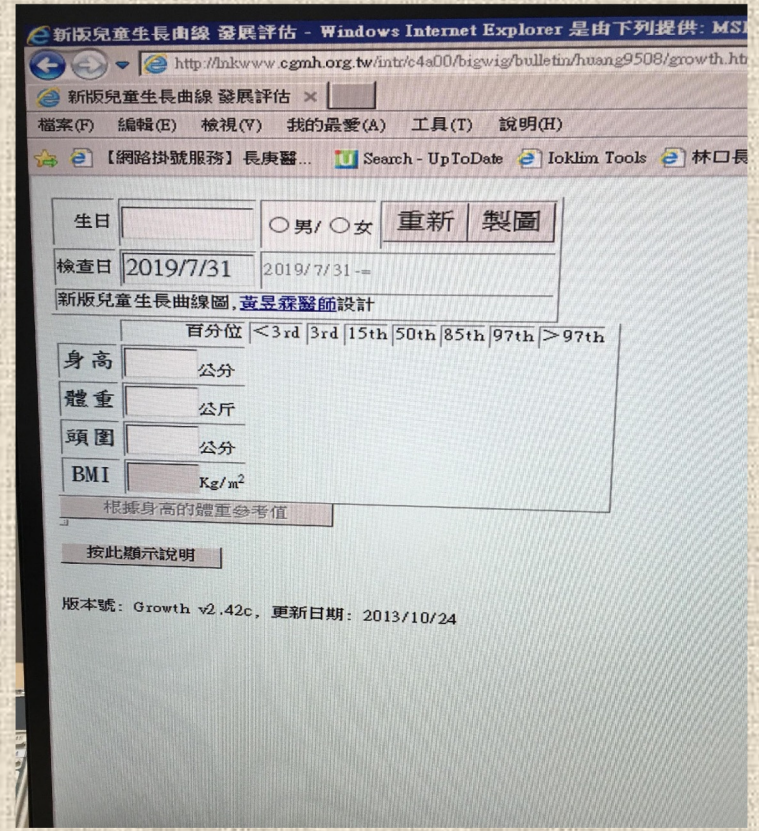
- 務必在general data貼上病人身高體重生長曲線趨勢

→ 每台電腦我的最愛→ iloklim tool→**新版兒童生長曲線 發展評估**

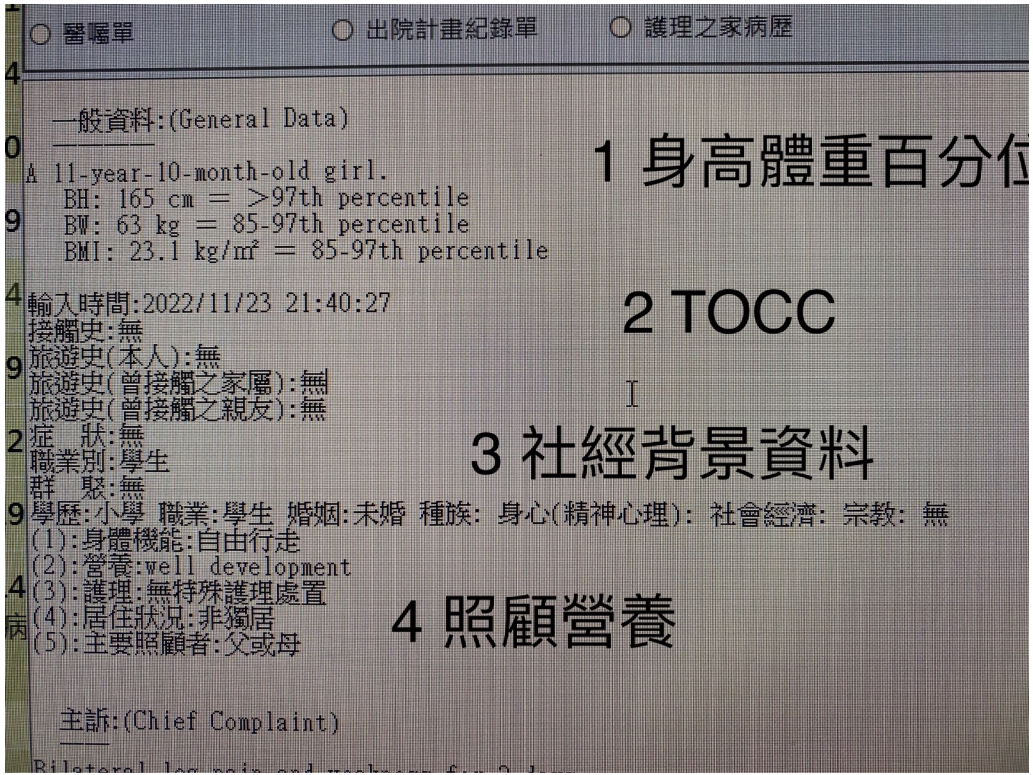
- 抽菸喝酒檳榔，小於8歲要附註NKA
- 疫苗史請務必參照健兒手冊及疫苗表，勿直接帶入範本
- Lab data & exam 需有intepretation
- 每個月會有病歷評核 (**需要被評核者回覆意見，請記得回覆填寫**)

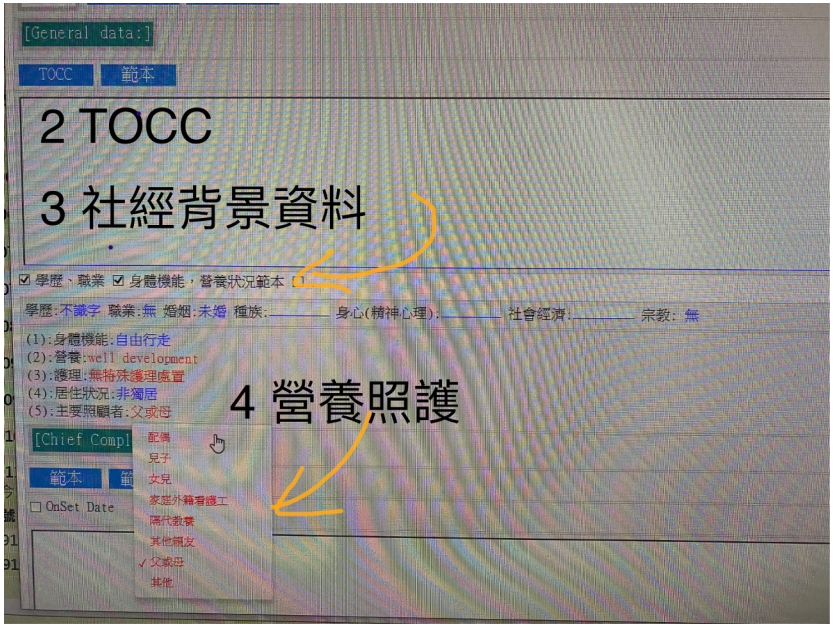

是由下列提供: MSN and Bing
搜尋...
加到我的最愛
我的最愛
摘要
歷程記錄
我的最愛列
行政院衛生署中央健康保險局
解醫事卡專屬網站
健康存摺-登入
Google 翻譯
Ioklim Tools
Home - PubMed - NCBI
林口長庚兒童內科部
【網路掛號服務】長庚醫療財團法人
http--lnkwww.cgmh.org.tw-intr-c4a00-newworkb..
開啟建議的網站...


http://lnkwww.cgmh.org.tw/intr/c4a00/bigwig/bulletin/huang9508/ioktoo
Ioklim Tools
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)
【網路掛號服務】長庚醫... Search - UpToDate Ioklim Tools
●新版兒童生長曲線 發展評估 v2.42
採用衛生福利部國民健康署最新兒童生長標準的生長計算工具。
五歲以前的兒童發展遲緩評估。
●舊版生長評估工具，新生兒評估工具
使用本工具請注意，自2009年5月18日起，衛生署國民健康局（現為衛生福利
工具採用的是2008年以前國民健康局的資料，與目前兒童健康手冊的資料有相
建議改用新版生長評估工具。
●NICU 2.41 NICU計算工具
NICU2.40有NICU所需要的大部分計算功能，並有智慧型輸入功能「★★」。功
★NEW!!★ 2.41版更正多項醫囑開立方式，並改正智慧型輸入的辨識能力。
想要使用本計算工具的同仁，務必先詳閱此說明書，謝謝。
●NICU IV fluid 計算工具
NICU輸液計算工具版本號v1.1，許凱翔醫師表單設計，黃昱霖醫師程式撰寫，2
能正確使用。
使用方式：將所有空白的數值填上後，按下「Keep 普通IV fluid:」按鈕即可。
本工具可以在任何電腦或手機的瀏覽器上運行，包括Windows PC、Mac、androi
●Pedigree 家族史產生器
本版使用滑鼠操作介面，完全取消代碼的輸入，而且按鈕只剩下一個，操作甚為
點一下，然後再點擊要使用的功能，就可以了。
●LabTable v.2.31 將院內Lab Data整理成表格的工具
利用檢驗查詢中的「複製報告」-->「門住診（粗略）」-->「該檢驗組別全部
資料整理成表格，將院內Lab Data整理成表格的工具，要將表格存回家存檔時請
程式所相容讀取。
●DKA Two Bag System Order Form v1.15
這是DKA在ICU的醫囑程式，本醫囑程式，已經經過PICU學長測試驗算過，已實際
醫囑。詳細說明已在程式本身中了。
●PICU fluid PICU輸液計算工具
資產編號
A5A0012820


新版兒童生長曲線 發展評估 - Windows Internet Explorer 是由下列提供: MSN
http://lnkwww.cgmh.org.tw/intr/c4a00/bigwig/bulletin/huang9508/growth.ht
新版兒童生長曲線 發展評估
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)
【網路掛號服務】長庚醫... Search - UpToDate Ioklim Tools 林口長
生日
○男/○女
重新
製圖
檢查日 2019/7/31
2019/7/31 -=
新版兒童生長曲線圖,黃昱霖醫師設計
百分位 <3rd 3rd 15th 50th 85th 97th >97th
身高 公分
體重 公斤
頭圍 公分
BMI Kg/m²
根據身高的體重參考值
按此顯示說明
版本號: Growth v2.42c, 更新日期: 2013/10/24

General data 範本





Progress note

- 病房每日一份progress note，ICU 每日兩份。
- 一週一份weekly summary，請於週五書寫，若遇到週五放假則改週四書寫(當週最後上班日為主)
- 藥物劑量(antibiotics, antiepileptic drug, steroid等)及檢查indication請紀錄在病歷中
- 每日需紀實V.S comments，一週至少記錄兩次teaching

Discharge note

- 週一檢查星期六日未完成出院病歷
- 務必於病人出院24小時內完成並電子簽章

- 開立Discharge order若有疑慮，要跟護理師確定是否有跟到查房確定是否VS說過要開立出院，若否請記得跟VS確認以防放走需開立AAD的case（特別是假日值班時！）

Duty note

- 假日duty note 請當層樓值班醫師幫忙書寫
- Holiday note!!
- 值班若病人有特殊狀況做處理可打duty note以供日後當科參考
- 病人轉至ICU請務必記錄transfer note

On/Off service note

- On service note接off service note or transfer note
- 每月的最後一天應確實交班給下位primary care住院醫師並寫Off service note

會議及教學活動

兒科會議

實體晨會請準時7:30參加

	W1	W2	W3	W4	W5
07:30-08:30		**兒科晨會**	**兒科晨會**		**兒科晨會**
07:30-08:30	次專科晨會			次專科晨會	
12:00-13:00	次專科科會		次專科科會	次專科科會	
12:20-13:00		Noon meeting			Noon meeting

晨會

- 每星期二、三、五，有時候會為全院演講，以附表列的時間為主。
- 每週會寄當週教學活動於信箱中。
- 早上7:30於12 K大會議室舉行。如果是跨院視訊會議則於大會議室旁邊的會議室舉行。
- 請各位PGY醫師坐在前四排（會議室柱子之前的座位）。

次專科會議

- 各次專科晨會通常於每星期一或四舉行，有些科會有些異動，請參照各科orientation表定時間。
- Journal reading, research meeting, combine conference, etc 請務必參加及簽到。

Noon meeting

- **每星期二及星期五中午12:20** 於12L討論室舉行
- 備有餐點請踴躍參加，並記得在當天早上晨會登記(放在簽到表旁邊:午餐麵包便當登記表)

門診/住診/急診/PGY核心課 教學 (教學活動>臨床!!)

- 教學門診(一診共門診病歷表*3、教學門診記錄表*1、 Mini-Cex評估表*1/人)
- 健兒門診/一般門診教學(一份健兒門診/一般門診紀錄)
  -> *欲跟診某位醫師請提前在當天打電話告知該醫師
- 教學住診(每週一張住診教學紀錄表，一個月共四張)
- 兒急急診教學(for PGY2兒科組 & R1 & 輪訓急診 R2R3)(急診學習紀錄表)
- PGY核心課程(簽到表一張，請記得看自己是不是當天值日生要記得去12L拿簽到表。核心課程如果是急診醫師上課請記得多拿一份急診學習紀錄表做紀錄)

門診/住診/急診/PGY核心課 教學 (教學活動>臨床!!)

- 若想跟當科主治醫師的門診請務必提前告知並取得同意
- 若有借其他間門診椅子須歸還，請由正門歸還椅子，不要從側門（門診會有護理師接應才不會影響到醫師看診）
- 請按照排程準時參加及簽到，勿擅自缺席
- 表單可於9L醫師讀書室拿取，表單完成後交至12L兒科舊辦公室信箱內，或至綜合大樓2樓兒科辦公室交給秘書
- 若想更動時間請自行找人互換，確定更動之後聯絡教學CR(GSM 89203, or tempro找馬于婷)
- 若有教學門診和急診教學的時間撞期的情況，也請聯絡教學CR

一診共3份

_林口_院區_兒童內_科　　教學☑門診☐住診病歷表

日期：_____年 __月 __日

姓名	部份姓名請以○呈現	病歷號碼		性別	☐男 ☐女	出生日期	年 月 日	本表由

說明：1. 病歷記載需包含病人的鑑別診斷、病歷書寫、理學檢查、診斷、檢查及用藥等內容。

2. 指導醫師需注意被指導者看診的溝通技巧與醫病關係之建立的教學指導，指導後需於每
並簽名。

_林口_院區_兒童內_科　　教學門診記錄表

☐已徵得病人同意教學

一診共1份

指導醫師：_____

指導日期：_____年 __月 __日 ☐上午診 ☐下午診 ☐夜診

教學對象：☐五六年級實習醫學生____人(請自行簽名)

姓名：_____, _____, _____

_____, _____

☐（中、牙）醫學系最後一年實習醫學生____人(請自行簽名)

姓名：_____, _____, _____

_____, _____

☐畢業後一般醫學訓練學員____人(請自行簽名)

姓名：_____, _____, _____

_____, _____

☐住院醫師___人(請自行簽名)

姓名（職級）：_____, _____, _____

_____, _____

病例來源：☐指導醫師約診病人 ☐初診病人

看診人數：☐約診_____人 ☐ 初診_____人 共_____人

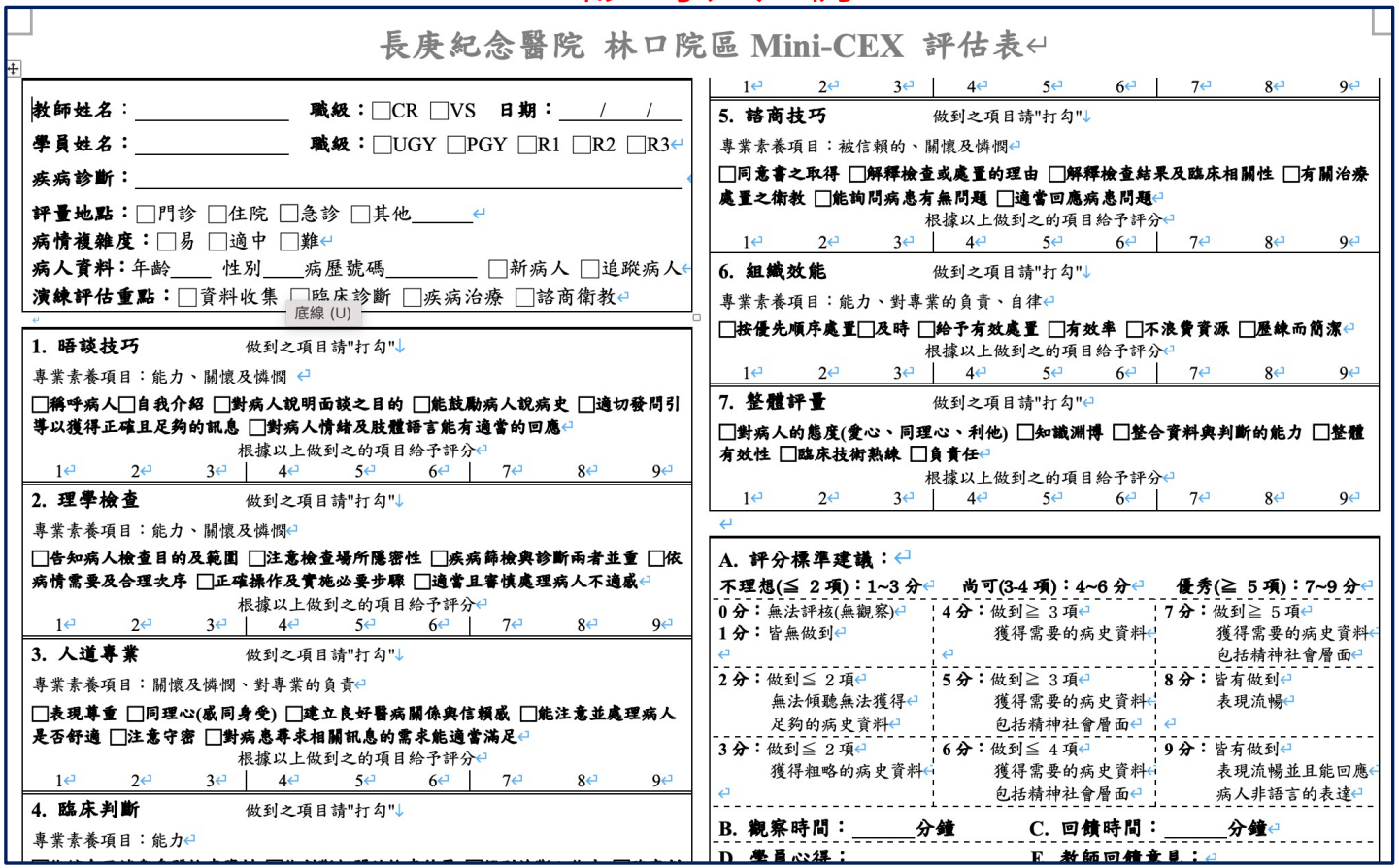
教學病例病歷號碼：

_____, _____, _____, _____, _____,

_____, _____, _____, _____, _____,

本聯由指導醫師指派受訓練學員記錄，經指導醫師批閱並簽名確認後，於開診日起算兩個

一診每人1份



長庚紀念醫院 林口院區 Mini-CEX 評估表

教師姓名：_____ 職級：☐CR ☐VS 日期：___/___/___

學員姓名：_____ 職級：☐UGY ☐PGY ☐R1 ☐R2 ☐R3

疾病診斷：_____

評量地點：☐門診 ☐住院 ☐急診 ☐其他_____

病情複雜度：☐易 ☐適中 ☐難

病人資料：年齡____ 性別____病歷號碼_____ ☐新病人 ☐追蹤病人

演練評估重點：☐資料收集 ☐臨床診斷 ☐疾病治療 ☐諮商衛教

底線 (U)

1. 晤談技巧 做到之項目請"打勾"

專業素養項目：能力、關懷及憐憫

☐稱呼病人☐自我介紹 ☐對病人說明面談之目的 ☐能鼓勵病人說病史 ☐適切發問引導以獲得正確且足夠的訊息 ☐對病人情緒及肢體語言能有適當的回應

根據以上做到之的項目給予評分

1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9

2. 理學檢查 做到之項目請"打勾"

專業素養項目：能力、關懷及憐憫

☐告知病人檢查目的及範圍 ☐注意檢查場所隱密性 ☐疾病篩檢與診斷兩者並重 ☐依病情需要及合理次序 ☐正確操作及實施必要步驟 ☐適當且審慎處理病人不適感

根據以上做到之的項目給予評分

1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9

3. 人道專業 做到之項目請"打勾"

專業素養項目：關懷及憐憫、對專業的負責

☐表現尊重 ☐同理心(感同身受) ☐建立良好醫病關係與信賴感 ☐能注意並處理病人是否舒適 ☐注意守密 ☐對病患尋求相關訊息的需求能適當滿足

根據以上做到之的項目給予評分

1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9

4. 臨床判斷 做到之項目請"打勾"

專業素養項目：能力

1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9

5. 諮商技巧 做到之項目請"打勾"

專業素養項目：被信賴的、關懷及憐憫

☐同意書之取得 ☐解釋檢查或處置的理由 ☐解釋檢查結果及臨床相關性 ☐有關治療處置之衛教 ☐能詢問病患有無問題 ☐適當回應病患問題

根據以上做到之的項目給予評分

1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9

6. 組織效能 做到之項目請"打勾"

專業素養項目：能力、對專業的負責、自律

☐按優先順序處置☐及時 ☐給予有效處置 ☐有效率 ☐不浪費資源 ☐歷練而簡潔

根據以上做到之的項目給予評分

1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9

7. 整體評量 做到之項目請"打勾"

☐對病人的態度(愛心、同理心、利他) ☐知識淵博 ☐整合資料與判斷的能力 ☐整體有效性 ☐臨床技術熟練 ☐負責任

根據以上做到之的項目給予評分

1 2 3 | 4 5 6 | 7 8 9

A. 評分標準建議：

不理想(≦ 2 項)：1~3 分	尚可(3-4 項)：4~6 分	優秀(≧ 5 項)：7~9 分
0 分：無法評核(無觀察) 1 分：皆無做到	4 分：做到≧ 3 項 獲得需要的病史資料	7 分：做到≧ 5 項 獲得需要的病史資料 包括精神社會層面
2 分：做到≦ 2 項 無法傾聽無法獲得 足夠的病史資料	5 分：做到≧ 3 項 獲得需要的病史資料 包括精神社會層面	8 分：皆有做到 表現流暢
3 分：做到≦ 2 項 獲得粗略的病史資料	6 分：做到≦ 4 項 獲得需要的病史資料 包括精神社會層面	9 分：皆有做到 表現流暢並且能回應 病人非語言的表達

B. 觀察時間：_____分鐘 C. 回饋時間：_____分鐘

D. 學員心得： E. 教師回饋意見：

____院區_____科　　教學住診記錄表

□已徵得病人同意教學

時間	年　月　日　點　分	地點：	指導醫師		記錄學員	

教學病例床號：_____病歷號碼：_____

基本資料：(年齡、性別、入院主訴或診斷)

每週1張，一個月共4張

參加者簽名：

主治醫師：_____

住院醫師：_____

畢業後一般醫學訓練學員：_____

(中、牙)醫學系最後一年實習醫學生：_____

五六年級實習醫學生：_____

病情概述：

教學內容與主要討論重點：(請勾選教學主題(可複選)後，於病歷記錄表摘錄教學內容)

全人	全隊
生理： □病人照護與臨床技能 □醫學知識	□跨領域團隊照護 □護理 □藥事 □醫事放射 □醫事檢驗 □營養 □呼吸治療 □物理治療 □職能治療 □臨床心理 □語言治療 □牙體技術 □聽力

本表由訓練學員記錄，經指導醫師批閱並簽名確認後，於實施當日起算兩個月內送交教學

長庚紀念醫院林口院區兒童內科健兒/一般門診教學記錄表

指導醫師：_____　　日期：___年 __月 __日

□上午診 □下午診

教學對象：□五六年級實習醫學生____人(請自行簽名)

姓名：_____, _____, _____

_____, _____

□七年級實習醫學生____人(請自行簽名)

姓名：_____, _____, _____

_____, _____

□畢業後一般醫學訓練學員(PGY)____人(請自行簽名)

姓名：_____, _____

_____, _____

□住院醫師___人(請自行簽名)

姓名（職級）：_____, _____

病例來源：□指導醫師約診病患 □初診病患

看診人數：□約診_____人 □ 初診_____人

教學病例病歷號碼：

_____, _____, _____, _____

本聯由指導醫師指派接受一名訓練學員記

一個月共1張

請事先填好
線上表單確
定診別

A	B	C	D	E	F	G	H
日期	主治醫師	PGY姓名1	PGY姓名2	下午健兒門診安排原則			
9/4（一）	賴美吟						
	許凱翔						
	徐任甫			1. 避開day off			
9/5（二）	賴美吟			2. 避開教學門診日			
	朱世明			3. 若教學門診為新生兒科的主治醫師, 可以選其他一般教學門診			
	林瑞瑩			每診不超過兩人			
	林如立						
9/6（三）	吳怡萱						
	楊長佑						
9/7（四）	許凱翔						
	朱世明						

林口院區 兒童內科部 急診學習記錄表

☐已徵得病人同意教學

時間	年 月 日 點 分	地點：	指導醫師		紀錄學員	

項目	病歷號碼	年齡	性別	入院主訴或診斷	其他
1.					☐新的急診病患 ☐觀察床
2.					☐新的急診病患 ☐觀察床
3.					☐新的急診病患 ☐觀察床
4.					☐新的急診病患 ☐觀察床
5.					☐新的急診病患 ☐觀察床

教學內容與主要討論重點：(請勾選教學主題後並摘錄教學內容，可複選)

☐醫學知識

☐病人照顧與臨床技能

☐人際與溝通技巧

☐實證醫學

本表由訓練學員記錄，經指導醫師批閱並簽名確認後，於實施當日起算一週內送交兒童內

- PGY核心課(急診)：共1份
- PGY2兒科組急診教學：1份/人

宣導

- 兒童大樓12L辦公室後門請協助保持上鎖，若因上課或會議所需可以暫時unlock，結束後也請務必復原！



兒科常見主訴

常見主訴

1. 喘
2. 疹子
3. 肚子痛
4. 抽筋
5. 血壓怪怪的
6. 心跳太慢
7. 檢查無法配合

兒科結束我要會的事

護理師摳你：

剛剛有個發燒從急診進來住院的小孩

媽媽說他一直在吐

醫師可以幫我看一下嗎？

兒科結束我要會的事

護理師摳你：

剛剛有個發燒

媽媽說他一直

醫師可以幫我看一下嗎？

我們心中有幾種DD

兒科結束我要會---DDx

- 相關器官至少三個
- 不相關器官至少三個

心中的DDx

- 相關器官至少三個
  - AGE
  - Acute abdomen: including intussucception, appendicitis, Intestinal malrotation, adesion ileus
  - Constipation
  - Pica/foreign body

- 不相關器官至少三個
  - Heart failure, myocarditis, shock
  - DKA
  - Postussive vomiting
  - IICP sign: meningitis

兒科結束我要會---評估

護理師摳你：

剛剛有個發燒從急診進來住院的小孩

媽媽說他一直在吐

醫師可以幫我看一下嗎？

小孩是幾歲幾公斤? Acute abdomen?

吐什麼？ 有其他症狀嗎？

PE？

需要抽血或做image？

有哪些藥可以用？

什麼時候再關心這家人？

要不要跟上線或主治說？

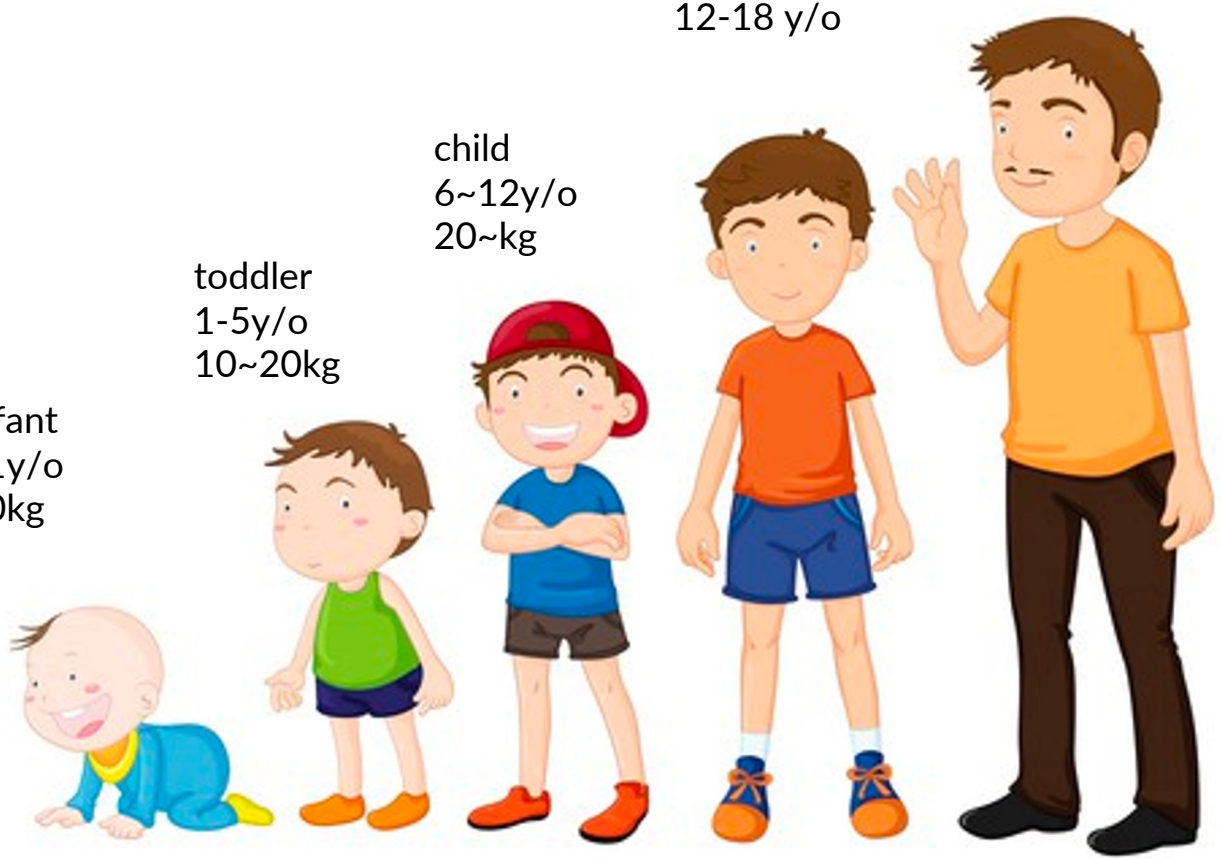
藥物

adolacent
12-18 y/o

child
6~12y/o
20~kg

toddler
1-5y/o
10~20kg

infant
~1y/o
10kg



點滴

- Maintenance fluids calculation
- 4-2-1 (mL/hr) or 100-50-20 (mL/day)
  - <10 kg：流速= BW x 4 mL/hr
    - Daily maintain = BW x 100 mL/day
  - 10-20 kg: 流速 = 40+ (BW-10) x 2 mL/hr
    - Daily maintain = 1000 + (BW-10) x 50 mL/day
  - > 20 kg: 流速 = 60+ (BW-20) x 1 mL/hr
    - Daily maintain = 1500 + (BW-20) x 20 mL/day

	8-10歲以下(小小孩)	8-10歲以上(大小孩)	
一般點滴	D0.225S	D0.225S	
腸胃	Taita No.2	Taita No.3	含 K
腦炎	D2.5%, 0.45S	D5S	for brain edema

藥物劑量



- **針劑開mg，口服水劑開ml**
- 40kg以上可以當成人劑量，七歲左右可以考慮錠劑

- 病人特殊用藥(antibiotics,antiepileptic drug,sedation,steroid等)請務必於藥囑上**附註劑量，如Cefazolin 100mg/kg/day**
- 藥物劑量請務必查工作手冊!!! 請看清楚有些藥是**kg/dose**或 **kg/day** 很容易開錯。如有不確定一定要問上線!!
- 沒有在工作手冊裡的藥物請跟主治或R確認開立劑量
- 請注意藥水量，**超過10ml以上請再double check**

Antibiotics



Pneumonia	Augmentin or Tazocin Azithromicin or doxycyclin Cefuroxime, Ceftriaxone
Samonella	Ceftriazone
Meningitis	Vanco+ceftriazone +/- Acyclovir +/-Azithromicin or doxycyclin
UTI	Genta+Cefa
Young infant fever	Genta+Ampicillin Ampicillin+claforan
Cellulitis	Oxacillin, Vanco or Teico for MRSA

Augmentin劑量

IV form

- 小孩劑量為 以Amoxicilli計 100mg/kg/day(Q6H~Q8H)
- 本院的Augmentin IV 劑型為 Amoxicillin 1gm+Clavulanic acid 200mg
- 因此Augmentin算法應為**120 mg/kg/day (=30mg/kg/dose Q6H)**

PO form 原廠(Amoxicillin/Clavulanic acid(80mg/11.4mg))

- 一般感染,pneumonia, UTI等， 一般劑量為以amoxicillin計 20~40mg/kg/day
- →速算法: 體重除以4 ml BID
- AOM中耳炎需要高劑量，以 amoxicillin計80~90mg/kg/day
- →速算法:體重除以2ml BID

PO form 台廠(Amoxicillin/Clavulanic acid(50mg/12.5mg))

- 請不要用速算法！

Ceftriaxone劑量

- 一般ＡＧＥ

  50-75mg/kg/day(Q12H)
- Meningitis dose

  100mg/kg/day(Q12H)

Chloral hydrate劑量



- 開立 Chloral hydrate 需開立**Chloral hydrate鎮靜同意書**(存檔後自動跳出 or 同意書-麻醉科)及**電腦key Chloral hydrate鎮靜恢復紀錄表**(同意書畫面右上方)

- 一般檢查(CT,EEG等)劑量: 體重x 0.5 ml
- 2D echo劑量: 體重 x 0.6 ml
- MRI 檢查因檢查時間久又不能動，需要更高劑量:體重 x 1 ml
- Max: 1pc(30ml)
- Consciousness change者考慮減量

病房常用Sedation(很容易搞錯!)

- 同時須開立輕中度鎮靜同意書，電腦key中重度鎮靜恢復記錄表 (同意書右上方)

- Midazolam: **0.1 mg/kg/dose, max 5mg /dose**
  - 兩種劑型，一支1mL (5mg), 3mL (15mg)
- Ketamine: **1 mg/kg/dose ,max 50mg/dose**
  - 一支是500mg/10ml，請勿開立1pc

- Ex. 60kg 12歲弟弟midazolam 為5mg,ketamine 為50mg

其他藥物使用注意!

- **腎臟科病人禁用fleet enema**，因為會造成acute phosphate nephropathy，可能導致本來的underlying disease更嚴重！

值班急症

以腹瀉為例，參照口訣 LQQOPERA 事先整理病史內容

	意義	參考內容（以腹瀉為例）
L	Location：位置	腹部痛
Q	Quality：發作型態	・大便的狀態？（稀糊便？水瀉？） ・大便的顏色？氣味？ ・是否有黏液或血絲？
Q	Quantity/time course：發作歷時長短	・一天腹瀉幾次？ ・大概多少量？
O	Onset mode：疾病發作的型態或發作模式	・哪時會出現腹瀉的狀況？ ・過去是否有相關的事件出現？
P	Precipitating factors：環境或誘發因素	・腹瀉的誘發因子？ ・最近的飲食內容？
E	Exaggerating/exacerbating factors：加重因素	・腹瀉之後，吃東西會拉得更嚴重嗎？喝水也會拉嗎？
R	Relieving factors：緩解因素	・出現腹瀉後，有做哪些處置？ ・有沒有去看其他醫師？用藥？ ・狀況有比較改善嗎？
A	Accompanying/associated symptoms：伴隨症狀	除了腹瀉之外，還有伴隨哪些症狀？ ・是否有脫水：黏膜皮膚乾、尿量變化、哭的時候是否有眼淚？心跳快嗎？ ・有沒有發燒？腹痛？噁心嘔吐？肌肉痠痛？躁動不安？

Desaturation

- Normal? respiratory rate/pattern/breathing sound
- Asthma AE? Croup AE? Pneumonia AE?
- O2: O2 hood:1~2歲 2~5 歲: O2 N/C or mask heater?
- IV: hydration with 70~80% of maintain for Dry lung
- Monitor and re-evaluation

	Breathing sound	Inhalation	Other
Croup	stridors	bosmin	Dexa, O2 hood
Asthma	wheezing	combivent, terbutaline	Methylprednisolone
Acute bronchiolitis	wheezing	nil	O2 hood with heater
Pneumonia	crackles, decreased	Mucolytics: Jusomin, acetylcysteine, 3% NaCl	CPT

Seizure

無論真假, 一律以當真的態度處理

- Consciousness? Vital sign?
- 真的seizure?假的seizure?(閉眼, 手前後抖, 腳亂踢, 抬屁股, 用手壓會停)
- Semiology: ictal, postictal, aura, same with previous pattern
- O2
- IV:
  - 1. Valium(IV/4, R/2), 如果seizure未停止, 五分鐘後可以再給,
  - 2. Loading or reloading
  - 3. Failure for first valium, please inform LW
- Monitor: Saturation

check electrolyte(Ca/Na/K/Cl/Mg), lactate, Blood gas, CPK, Drug level

(+/- BUN, Cre, AST, ALT, Ammonia)

Shock

- Consciousness/Light reflex: AVPU(alert, voice, pain, unresponse)
- Capillary refilling/ warm or cold/ Vital sign
- Temperature, glucose
- Glucose: D10W 2ml/kg slowly iv push
- Challenge with N/S or L/R 10-20ml/kg
- Bosmin for anaphylatic shock (Please give IM!!)

<10kg	0.01mg/kg, 0.1mg
10-25kg	0.15mg
25-50kg	0.3mg
>50kg	0.3 mg or 0.5mg

Panic lab

- WBC >20,000, blast(+), Bandemia >5%, CRP >100
- Hb<7, PLT <20K
- B/C: GNB!!
- Sugar <50mg/dl

Emergent surgery

- GI: appendicitis, ischemia bowel, intussusception failure to reduction, vulvulus, adhesion ileus
- ID: septic arthritis, deep neck infection, orbital cellulitis
- Foreign body aspiration

IHCA


Early Recognition and Prevention
Activation of Emergency Response
High-Quality CPR
Advanced Resuscitation
Post-Cardiac Arrest Care
Recovery

OHCA


Prevention
Activation of Emergency Response
High-Quality CPR
Advanced Resuscitation
Post-Cardiac Arrest Care
Recovery

CPCR

Newborn(< 3month/o): NRP

- HR<60

- 雙手拇指放胸骨下方三分之一處 (**乳頭連線下方**)，但勿施壓於劍突，避免造成肋骨斷裂、氣胸

- 按壓深度胸部前後徑 1/3 的深度

- 每 2 秒胸部按壓 3 次後正壓 換氣一次



Infant <1y/o, child >1 y/o: APLS

- HR<60 with altered consciousness or asystole

- 掌根（單掌或雙掌）按壓兩乳頭連線中點下方

- 按壓深度胸部前後徑 1/3 的深度、每分鐘胸部按壓 100-120次

- 沒有高級呼吸道-> 15:2換壓通氣(if 2位以上施救者)
  有高級呼吸道-> 持續按壓, 2-3s通氣一次

